



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : اصلاح السيد مسعد على
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : الظاهر
رقم البطاقة : 26110211302303 رقم التليفون : 01113861446
العنوان : //
العمر (تاريخ الميلاد) : 21-10-1961 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 07-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: اصلاح السيد مسعد علي National ID: 26110211302303	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
--	--

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدى و تحتاج الى Further investigations and imaging
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





١٥ م

دوليكس
زومنا

مترين من الكلياء والفضوءات



Name: اصلاح السيد مسعد علي		
MR. : 8148		
Detailed Medical Report		
		السيد
تجبة طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient is a 64-year-old with triple-negative breast cancer (TNBC) and TCHP stage, who underwent left total mastectomy (LT MRM) in June 2023 and achieved a partial response with TON1 disease. Post-operative management included adjuvant PORT, KADCYLA, and Arimidex, with a planned 3-month continuation of therapy and a next visit scheduled for 23 August 2026, at which Zometa was to be administered. The patient remains on Arimidex plus supportive therapy, with a planned 3-month continuation of this regimen. A new evaluation is scheduled, including a chest X-ray (CXR) and pelvic ultrasound (PAUS). The patient reports vaginal spotting, prompting a transvaginal ultrasound (TVUS) to be performed. The patient has completed the current course of Arimidex plus supportive therapy as documented, with no additional cycle or week counts specified in the notes.		
تحريرا في ,		
	التاريخ :	19-09-2026
	الوقت :	
	الطبيب المعالج :	Mariam Adel Hafez
يعتمد ,		

بجاء التأمين
١

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION AND DECHON SUPPORT



الهيئة العامة للتأمين الصحي
الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات
ودعم القرار

جاءه الاصدار : فرع القاهرة

تاريخ الاصدار : 2023-1-18

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل" وكذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 "الاطفال دون السن المدرسي" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعية
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي
والبحث تبين أن

السيد (ة) اصلاح السيد مسعد بطاقة رقم 26110211302303
وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعة بالتأمين الصحي
وشكرا

تاريخ الطباعه : 2023-1-18

الموظف المختص

الهام صلاح



مسلسل 352284

الخطاب ساري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا في حالة تغيير حالة المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التربية والتعليم

الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات و دعم القرار



رجب ١٤٤٥
٢

MDT form

A-Patient ID:

1- Name : اصلاح السيد محمد علي

Sex:

3- Medical number:

Male

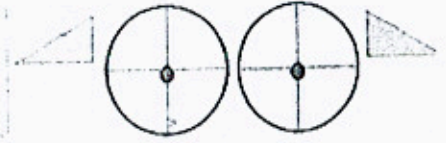
83121191

Old Med:

1984/2023

2-ID number: 26110211302303

Patient Age : 62 Y



Family history

Phone

01113057907

BMI

REASON OF MDT

POST OPERATIVE

marital status

NRS Score

GROUP

Date of MDT

2023-07-26

Co morbidity

Menopausal
status

POSTMENOPAUSAL

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

EX:	ER:	PR:	Her 2 Neu :	SISH :	KI67 :
T	N			M	

Sonomammography

PATIENT HISTORY

PATHOLOGY REPORT 25/6/2023-->LT MRM

NO VIABLE TUMOR TISSUE,,NO DCIS,,FREE NIPPLE AND AREOLA,,LN 1/12,,FREE RESECTION MARGIN
PARTIAL PATHOLOGICAL RESPONSE

MDT OUTCOME & PLAN

FOR ADJUVANT KADCYLA , PORT, ET (AI)

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	د/ شريف حسنين	RADIOLOGY	د/ تشوي عبدالقادر
SURGERY	د/ محمود عبدالنعم	PATHOLOGY	د/ ايمن علي
Psychiatric		Nutrition	

Patient Name : الأستاذ / اصلاح السيد مسعد	Request No. : 13005937
Patient No. : 26110211302303	Request Date : 21/01/2023
Path No. : sr-62/2023	Verification Date : 23/01/2023
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age : 61 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

CLINICAL DATA

Left breast mass.

NATURE OF SPECIMEN

Slide revision.

GROSS PATHOLOGY

One block labelled by (73/22) and three slides received.

Microscopic examination:

- Histological type: Invasive duct carcinoma.
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): GII (3+2+1).
- Lymphovascular emboli: Positive.
- Ductal carcinoma in situ: Focal (intermediate grade, cribriform).
- No perineural invasion.
- IPT:

ER: Strong nuclear reaction in 95% of tumor cells (Allred score 8/8).

PR: Faint nuclear reaction in 25% of tumor cells (Allred score 4/8).

Her-2: strong complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 3+).

Diagnosis:

Left breast mass; Slide revision:

- Invasive duct carcinoma GII with positive lymphovascular emboli and focal DCIS.

• IPT:

ER : Positive (8/8)

PR : Positive (4/8)

HER2 : Positive (score 3+)

Prof. Lubna Omar.

Dr.Menna Nabil.

Verified by :

DR.Menna Nabil

Printing Date : 17/06/2023 10:12:35

Page 1 of 2

Printing By : .marwa mohamed youss

PATIENT NAME: ISLAH ELSAYYED MOSAAD ALI	PATIENT ID #: 2022215454
GENDER: Female	ORDER #: 2103750,2103751
AGE: 61 y	DATE OF SERVICE: 14-Jan-2023 09:09 AM

Report: - all studies

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST,
ABDOMEN AND PELVIS WITH TRIPHASIC LIVER ASSESSMENT

1-CHEST

- Left breast LOQ irregular spiculated enhancing soft tissue lesion measuring about 3.6 x 4.5 cm. Retroareolar asymmetrical density measuring about 4 x 4.8 cm with parenchymal edema and overlying thickened skin.
- Left axillary level I lymph nodes, the largest measuring about 3.6 x 4.5 cm.
- Middle lobe and lower lobes atelectatic bands.
- No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No CT evidence of pathologically enlarged hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers.
- No pericardial effusion detected.

2- ABDOMEN AND PELVIS

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No definite focal lesions or area of pathological enhancement.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- Cholecystectomy with prominent extra hepatic biliary radicles.
- Normal appearance of the pancreas, spleen, kidneys, adrenals, aorta, I.V.C and the pelvic organs.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- No pathologically enlarged abdominal or pelvic lymph nodes.

PATIENT NAME: ISLAH ELSAYYED MOSAAD ALI	PATIENT ID #: 2022215454
GENDER: Female	ORDER #: 2070454,2070455
AGE: 61 y	DATE OF SERVICE: 02-Jan-2023 10:04 AM

Report: - all studies

FULL FIELD DIGITAL MAMMOGRAPHY AND COMPLEMENTARY ULTRASOUND

INDICATION:

- Screening.

TECHNIQUE:

- CC and MLO view.
- Complementary ultrasound

REPORT:

- Scattered fibroglandular densities (ACR B) with left breast edematous changes including thickened skin. The retro-areolar region shows a comparatively increased density? Part of the edematous changes.
- An irregular dense mass like asymmetry is seen in the left UOQ located more than 90mm away from the nipple. A circumscribed intramammary lymph node (showing a preserved hilum by ultrasound) is seen around 15mm away from it (measured in the CC view). Complementary ultrasound revealed an irregular heterogeneously hypoechoic mass seen at 3:00 measuring 52.8 x20x53.3mm in its respective TSxAPxCC diameters.
- The intramammary lymph node is peripherally seen at 2:00.
- No right breast spiculated mass lesions or grouped microcalcifications.
- This was confirmed by Complementary Ultrasound which showed no right breast solid or cystic mass lesions.
- Normal skin thickness and contour of the right breast.
- Normal nipple areola complexes.
- More than 3 axillary lymph nodes on the left side show an effaced hilum and an increased cortical thickness.
- Right breast non specific axillary lymph nodes.

OPINION:

Left breast malignant looking lesion with ipsilateral pathological lymph nodes, BIRADS 5.

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

اصلاح
السيد مسعد علي
١١ ش سوارس
الظاهر - القاهرة

١٩٩١/١٠/٢٣

٢٦١١٠٢١١٣٠٢٣

LZ4839657

National ID - Front
[DOCUMENT ID]

٢٠٢٦/٠٩ ٢٦١١٠٢١١٣٠٢٣٠٣
ربة منزل
أنثى
البطاقة سارية حتى ٢٠٣٣/٠٩/٢٦

